

monotropism-comorbidities- factcheck_pt

Comorbilidades monotrópicas: uma verificação do enquadramento de quatro clusters

Um brief de investigação citado — verificando um enquadramento amplamente partilhado de "comorbilidades monotrópicas".

Informativo, não conselho médico. O monotropismo é um estilo cognitivo, não um diagnóstico; não tem "comorbilidades" no sentido de doença. Este brief avalia o que as sobreposições com o enquadramento abaixo são e não são apoiadas como sendo. Complementa o brief panorâmico mais completo do projeto, "O monotropismo e a sua teia de comorbilidade".

Resumo executivo

- **A abertura do enquadramento é exatamente correta: o monotropismo não tem "comorbilidades" no sentido de doença.** É um estilo de atenção num espectro; as sobreposições com condições clínicas são *associações e mecanismos partilhados*, não sequelas de uma doença [1].
- **Uma alegação de destaque está ao contrário.** "As pessoas AuDHD pontuam mais alto de todos os grupos no MQ" **não** é o que os dados mostram. No estudo de validação do MQ, o autismo e o TDAH cada um aumentam as pontuações de monotropismo, mas o seu efeito *combinado* é uma **interação negativa** ($\beta = -0,43$, $p < ,001$): pessoas autistas-com-TDAH pontuam **mais baixo do que um modelo puramente aditivo preveria**, não mais alto [2].

- **Dois termos estão corretamente atribuídos mas precisam de definições precisas.** A "*cisão monotrópica*" (*monotropic split*) é genuinamente cunhada pela advogada autista **Tanya Adkin** — mas significa o custo cognitivo de *forçar uma mente monotrópica a operar de forma polytrópica* (dividindo a atenção), **não** os "túneis AuDHD concorrentes" com os quais é por vezes confundida [3].
- **"Problemas de permanência do objeto" são contestados, não estabelecidos.** A *única* fonte académica (Lawson & Dombroski, 2017) propõe **atrasada** permanência do objeto como uma *hipótese* para algum stress relacionado com o autismo — e a literatura mais ampla descobre que a permanência do objeto é tipicamente *intacta ou superior* no autismo. A experiência "fora da vista, fora da mente" lê-se melhor como um efeito de **memória de trabalho / alocação de atenção** [4].
- **O resto é amplamente apoiado mas graduado por evidência.** Autismo (fundacional), hiperfoco do TDAH (real), sobreposição ansiedade/ruminação e TOC (robusta), inércia autista (real), sobrecarga sensorial → meltdown/shutdown (real), e burnout por transições forçadas + camuflagem (construto estabelecido) sobrevivem todos ao escrutínio — com a hiper-sistematização a ser a **teoria E-S separada de Baron-Cohen**, não uma descoberta do monotropismo [5].
- **Um reenquadramento neuroafirmativo:** cada sobreposição enuncia-se melhor como "*como um sistema de atenção estreito e intenso interage com um mundo polytrópico*" em vez de como uma lista de perturbações que um cérebro monotrópico "causa".

1. O princípio central (o enquadramento acerta nisto)

O monotropismo (Murray, Lawson & Lesser, 2005) sustenta que as mentes diferem em *como alocam atenção*: uma mente monotrópica concentra recursos em poucos "túneis de atenção" intensamente ativados; uma mente polytrópica espalha-os por muitos [1]. Porque é um **estilo cognitivo dimensional** — mensurável no Monotropism Questionnaire (MQ) numa escala de 1–5 — não "tem comorbilidades". O que *tem* são **associações estatísticas** (grupos que pontuam mais alto) e

mecanismos partilhados (condições cujas características uma lente de alocação de atenção ajuda a explicar). Manter essa distinção é todo o jogo [1][2].

Este brief está organizado como uma **verificação alegação-por-alegação** do enquadramento de quatro clusters, graduando cada item. Complementa (não repete) o brief panorâmico existente do projeto, que cobre perturbações alimentares, acumulação, agorafobia, evitamento de exigências e o problema da dupla empatia mais aprofundadamente.

2. Cluster 1 — Perfis neurodivergentes centrais

Autismo (fundacional, ligação mais forte)

O monotropismo foi *criado* para explicar traços autistas — interesses especiais intensos, necessidade de rotina (que protege o túnel de atenção), e diferenças na interação social [1]. O MQ confirma-o empiricamente: participantes autistas tiveram em média **4,15/5** vs **3,19/5** para participantes não-autistas (n=1.110) [2]. Este é o terreno nativo da teoria e a ligação melhor documentada.

TDAH (real e medido)

O TDAH aumenta significativamente as pontuações de monotropismo ($\beta = +0,55$, $p < ,001$) [2]. A ligação é conceptual assim como estatística: o **hiperfoco** do TDAH (Grotewiel et al., 2022, sobre hiperfoco como construto distinto) é quase idêntico conceptualmente ao túnel monotrópico, e a "disfunção executiva" de ativar atenção para tarefas não interessantes é uma predição natural de um sistema em túnel [2][6].
Apoiado.

AuDHD (a alegação de destaque está ao contrário) — a correção-chave

***Alegação verificada:** "Pessoas com um perfil AuDHD combinado pontuam mais alto de todos os grupos no MQ."*

Isto não é o que os dados mostram. A regressão múltipla do artigo do MQ regrediu o monotropismo no estatuto de TDAH, estatuto de autismo, e na sua **interação** [2]:

Preditor (vs nenhuma das condições)	β	p
TDAH, não autista	+0,55	<,001
Autista, não TDAH	+1,04	<,001
Interação Autismo × TDAH	-0,43	<,001

O termo de interação é **negativo e significativo**. Os autores afirmam-no claramente: *"as pontuações de monotropismo não são tão altas para indivíduos autistas com TDAH como seria de esperar com base em efeitos puramente aditivos"* [2]. Por outras palavras, adicionar TDAH ao autismo **não** empurra o monotropismo para mais alto do que o autismo sozinho prediria — fica **mais baixo** do que a soma dos dois efeitos independentes.

- O **grupo único que pontua mais alto** são as pessoas autistas (4,15); se a *média da célula* empírica para autista-com-TDAH se situa logo acima ou abaixo disso depende da combinação exata, mas a alegação do enquadramento de que AuDHD é *"o mais alto de todos"* como efeito aditivo/super-aditivo é **não apoiada e contraditada pela interação**.
- A imagem *intuitiva* que o enquadramento oferece — "uma tração interna entre a necessidade autista de um túnel estável e profundo e o ímpeto do TDAH por input novo" — é uma descrição popular e fenomenologicamente ressonante da experiência AuDHD, mas é **narrativa clínica/comunitária, não uma descoberta de pontuação do MQ**. Enuncie-a como experiência vivida, não como um resultado do MQ [6].

Afirmação corrigida: *"Tanto o autismo como o TDAH aumentam independentemente as pontuações de monotropismo, mas os dois interagem de forma não aditiva: pessoas autistas com TDAH pontuam mais baixo no MQ do que um modelo puramente aditivo preveria — sugerindo que as duas condições não simplesmente se 'empilham' na tendência monotrópica."* [2]

3. Cluster 2 — Traços cognitivos e de saúde mental

Ansiedade e ruminação (associação robusta, mecanismo plausível)

A ansiedade e a ruminação estão elevadas na população autista/TDAH, e o enquadramento do monotropismo oferece um mecanismo limpo: uma mente em túnel que se agarra a uma preocupação processa-a em ciclo ("ruminação"), tornando a ansiedade "pegajosa" [7][8]. A estrutura de 8 fatores do MQ inclui mesmo uma subescala de "**ruminação e ansiedade**", mostrando que o cluster é empiricamente justo [2].

Apoiado — embora note que a seta causal (o monotropismo *produz* ansiedade, ou partilha um substrato com ela?) não está estabelecida.

TOC (sobreposição robusta, distinção importante)

A sobreposição autismo–TOC é real e replicada. Uma meta-análise descobre que aproximadamente **~17% das pessoas autistas cumprem os critérios de TOC** (vs ~1–2% na população em geral); o inverso também está elevado [9]. A distinção qualitativa que o enquadramento traça é exatamente correta e bem articulada: **interesses monotrópicos são ego-sintónicos** (impulsionados por fascínio/alegria), enquanto **compulsões do TOC são ego-distónicas** (impulsionadas por angústia e executadas para neutralizar o medo) [10]. Esta distinção é clinicamente importante porque as duas podem de outra forma ser difíceis de distinguir na prática. **Apoiado.**

Hiper-sistematização (construto real, mas é de Baron-Cohen, não uma descoberta do monotropismo)

A "hiper-sistematização" — o ímpeto de analisar, construir e explorar sistemas — é um traço autista genuíno e bem investigado, mas pertence à **teoria Empathizing–Systemizing (E-S)** de Simon Baron-Cohen, não ao monotropismo [5]. As duas teorias sobrepõem-se fortemente (ambas descrevem um estilo cognitivo intenso e focado no detalhe) e são por vezes confundidas, mas são **enquadramentos distintos** com medidas distintas (o quociente EQ/SQ vs o MQ). O movimento honesto: apresente a hiper-sistematização como *consistente com* um estilo monotrópico (uma mente em túnel está bem dotada para dominar sistemas) enquanto credita a teoria E-S como sua própria coisa [1][5].

4. Cluster 3 — Fenómenos neurológicos e de processamento

Problemas de permanência do objeto ✗ (contestado — a segunda correção-chave)

Alegação verificada: *"Indivíduos monotrópicos experimentam a permanência do objeto de forma diferente ... o cérebro efetivamente para de processar a sua existência até que algo exogenamente os puxe de volta."*

Esta é a **alegação mais fraca** no enquadramento e precisa de manuseamento cuidadoso:

- Há **uma** fonte académica que propõe uma ligação de permanência do objeto: **Lawson & Dombroski (2017)**, que *hipotetiza* que a **atrasada** permanência do objeto pode contribuir para algum stress e ansiedade relacionados com o autismo [4]. Nota: é um artigo de construção de hipóteses, não um estudo de confirmação.
- A literatura de desenvolvimento mais ampla descobre que a **permanência do objeto básica é tipicamente intacta ou superior no autismo**; as tarefas piagetianas de permanência do objeto são normalmente passadas em idades típicas [4].
- O fenómeno *real* que o enquadramento procura — "fora da vista, fora da mente" para tarefas, objetos e até pessoas — é melhor explicado como um efeito de **memória de trabalho / alocação de atenção**: uma mente em túnel não *falha* em representar o item, ela **falha em reorientar a atenção de volta para ele**. Isso é o monotropismo a funcionar como previsto (um sistema em túnel tem poucos recursos livres para reorientação periférica), não um défice de permanência do objeto [1][4].

Afirmação corrigida: *"A experiência 'fora da vista, fora da mente' em pessoas altamente monotrópicas compreende-se melhor como um efeito de alocação de atenção / memória de trabalho — a mente representa o item mas não se reorienta para ele enquanto em túnel — em vez de um défice na permanência do objeto (que é tipicamente intacta no autismo)." [1][4]*

Desregulação sensorial / sobrecarga (mecanismo bem apoiado)

Isto é fortemente apoiado. Porque um sistema em túnel gasta os seus recursos centralmente, um input sensorial intrusivo repentino (sirene, luz, toque) exige uma realocação dispendiosa — vivenciada como uma "rutura violenta". Isto alinha-se com a literatura estabelecida de hiper-responsividade sensorial e a rota bem documentada da sobrecarga sensorial para **meltdown** (externalizante) e **shutdown** (retirada internalizante), ambos reconhecidos como respostas involuntárias de sobrecarga [7][11]. O enquadramento do monotropismo adiciona um *mecanismo* (custo de realocação) ao que de outra forma é uma descoberta descritiva. **Apoiado**.

Inércia autista (real, cada vez mais investigada)

A "dificuldade profunda com transições — problemas em iniciar, parar ou mudar de direção" é o construto estabelecido de **inércia autista**: dificuldade com iniciação/terminação/alternância de tarefas que "não está sob controlo consciente", primeiro articulada em narrativas comunitárias autistas e agora em trabalho revisto por pares [12][13]. É conceptualmente a face *comportamental* do "custo de mudança" que o fator ambiente-e-túnel do MQ capta [2]. **Apoiado** — e é o termo técnico correto (veja o brief complementar sobre pontuação/inércia).

5. Cluster 4 — Resultados de stress crónico

Cisão monotrópica (corretamente atribuída a Adkin, mas dois significados são confundidos)

***Alegação verificada:** "Cisão monotrópica, cunhada pela prática Tanya Adkin, ocorre quando uma mente monotrópica é forçada pelo seu ambiente a dividir o seu canal de foco único através de múltiplas correntes concorrentes."*

A **atribuição está correta**: a advogada autista **Tanya Adkin** cunhou efetivamente "monotropic split", confirmada por múltiplas fontes comunitárias independentes [3]. E a definição do enquadramento aqui está **perto do significado real de Adkin** — o custo cognitivo/burnout

que surge quando uma mente monotrópica é *forçada a "desempenhar polytropicamente"* ou a dividir a sua atenção através de correntes concorrentes [3][14].

Duas ressalvas:

1. **É um conceito comunitário/de prática, não um construto empiricamente validado.** "Monotropic split" aparece na escrita comunidade-autista e clínica (ex. via Neurodivergent Insights, Kelly Mahler, David Gray Hammond) mas **não tem um estudo de validação revisto por pares** por trás de si [3]. Trate-o como uma poderosa *descrição* válida por experiência vivida, não uma entidade medida.
2. **Dois coisas diferentes viajam sob o nome.** O sentido de Adkin = *desempenho polytrópico forçado por uma mente monotrópica* (um problema de compatibilidade ambiental). Um segundo sentido — usado em alguma escrita AuDHD — = *a competição interna entre uma necessidade autista de um túnel estável e um ímpeto de TDAH por novidade* (um problema de dinâmica interna). O enquadramento aqui descreve o **primeiro** (ambiental) sentido. Estes são relacionados mas distintos; colapsá-los turva o conceito. (O brief panorâmico do projeto usa "monotropic split" no segundo sentido AuDHD — então o termo é genuinamente sobrecarregado no campo.) [3][6]

Enuncie-o como: "O termo 'cisão monotrópica' da advogada autista Tanya Adkin descreve o custo cognitivo e burnout que surgem quando uma mente monotrópica é forçada a operar de forma polytrópica — um poderoso conceito comunitário que aguarda validação formal." [3]

Burnout  (construto estabelecido; a ligação ao monotropismo é heurística)

O burnout autista é agora um construto bem definido: **exaustão crónica, perda de competências e tolerância reduzida ao estímulo**, conceptualizada como resultante de stress de vida crónico e "uma incompatibilidade de expectativas e capacidades" sem apoio e recuperação adequados (Raymaker et al., 2020; Higgins et al., 2021, um estudo Grounded-Delphi com especialistas autistas) [15][16]. O caminho do monotropismo para o burnout — transições forçadas constantes, camuflagem e "cisão monotrópica" a drenar recursos sem tempo de

recuperação/fluxo — é **heurístico poderoso e validade pela comunidade**, mas a contribuição *específica* da rutura do túnel para o burnout (versus camuflagem, trauma, carga sensorial, procura crónica) **não foi isolada experimentalmente** [15]. **Apoiado como uma hipótese forte, não como uma cadeia causal estabelecida.**

6. Uma folha de pontuação graduada

Alegação no enquadramento	Veredito	Nota
O monotropismo não tem comorbilidades-doença	✓ Correto	Tem associações + mecanismos partilhados [1]
Autismo = ligação primária	✓ Fundacional	MQ 4,15 vs 3,19 [2]
O TDAH aumenta o monotropismo	✓ Apoiado	$\beta = +0,55$ [2]
AuDHD pontua mais alto de todos	✗ Ao contrário	A interação é negativa ($\beta = -0,43$) [2]
Sobreposição ansiedade e ruminação	✓ Robusta	O MQ tem um fator ruminação/ansiedade [2]
Sobreposição TOC (ego-sintónico vs distónico)	✓ Apoiado	~17% de co-ocorrência; distinção correta [9][10]
Hiper-sistematização	⚠ Real mas mal etiquetado	É a teoria E-S de Baron-Cohen, não monotropismo [5]
Problemas de permanência do objeto	✗ Contestado	1 artigo de hipótese; PO tipicamente intacta; é alocação de atenção [4]
Sobrecarga sensorial → meltdown/shutdown	✓ Bem apoiado	Mecanismo = custo de realocação [7][11]
Inércia autista	✓ Real	Termo correto; revisto por pares [12][13]
Cisão monotrópica cunhada por Adkin	⚠ Atribuição correta; comunitário, não validado	Dois significados confundidos [3]

Alegação no enquadramento	Veredito	Nota
Burnout por transições forçadas + camuflagem	✓ Construto estabelecido; ligação heurística	Não isolado experimentalmente [15][16]

7. Conclusões práticas

- **Abra com o princípio:** o monotropismo é um estilo de atenção mensurável cujas *sobreposições* com condições são associações e mecanismos partilhados — nunca "causa X." [1]
- **Cite o MQ corretamente:** o autismo e o TDAH cada um aumentam as pontuações, mas a combinação é **não aditiva (mais baixa do que o esperado)** — não diga que AuDHD pontua mais alto [2].
- **Mantenha a distinção ego-sintónico/ego-distónico** ao discutir TOC vs interesses especiais — é clinicamente útil e corretamente enquadrada [10].
- **Acredite enquadramentos precisamente:** hiper-sistematização = teoria E-S de Baron-Cohen; cisão monotrópica = conceito comunitário de Adkin (sentido ambiental de polytropia forçada); inércia autista = o construto revisto por pares de dificuldade de transição [3][5][12].
- **Largue "défice de permanência do objeto":** reenquadre como alocação de atenção / memória de trabalho, que é tanto preciso como mais útil para apoio [1][4].
- **Distinga validade vs heurístico:** o burnout é um construto estabelecido, mas o caminho monotropismo→burnout é uma hipótese forte, não um efeito medido; a "cisão monotrópica" é válida por experiência vivida mas não validada [3][15].

Fontes

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156. doi:10.1177/1362361305051398 — origem do monotropismo; uma diferença na alocação de recursos (um continuum), não um déficit. <https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (auto-relato de 47 itens; preprint de validação). Open Science Framework. — n=1.110; média autistas 4,15 (DP ,347) vs não-autistas 3,19 (DP ,578); regressão $\beta(\text{TDAH})=+0,55$, $\beta(\text{autismo})=+1,04$, **$\beta(\text{interacção})=-0,43$, $p<,001$** ; a interação TDAH+autismo é *sub-aditiva*; estrutura de 8 fatores incl. fatores ruminação/ansiedade e ambiente/túnel. <https://osf.io/wpx5g> · validação: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Arquivo local: `sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf`

[3] Adkin, T. — "monotropic split" (advogada autista / prática; conceito comunitário). Confirmado via múltiplas fontes comunitárias independentes: Neurodivergent Insights (glossário), Kelly Mahler (post convidado), David Gray Hammond, Jade Farrington ("Quando pessoas monotrópicas são forçadas a operar de forma polytrópica é conhecido como monotropic split"). Definição: o custo cognitivo/burnout de forçar uma mente monotrópica a "desempenhar polytropicamente". Conceito comunitário/de prática — **nenhum estudo de validação revisto por pares**. <https://jade-farrington.medium.com/what-is-monotropic-split-1c7c46fd9017> · <https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/interoception-and-monotropism>

[4] Lawson, W. & Dombroski, B. (2017). *Problems with Object Permanence: Rethinking Traditional Beliefs Associated with Poor Theory of Mind in Autism*. J. Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 5(1). doi:10.6000/2292-2598.2017.05.01.1 — *hipotetiza atrasada* permanência do objeto como contribuinte para algum stress relacionado com o autismo (um artigo de construção de hipóteses, não uma confirmação). Literatura mais ampla: a permanência do objeto é tipicamente intacta/superior no autismo; "fora da vista, fora da mente" lê-se melhor como alocação de atenção/memória de trabalho. Arquivo local: `sources/12-object-permanence-lawson-dombroski.pdf` · <https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/4562>

[5] Baron-Cohen, S. (2009/2010). *Autism and the empathizing–systemizing (E-S) theory; the hyper-systemizing theory of autism*. Annals of the NYAS; APA PsycNet. — a hiper-sistematização e a teoria E-S são o enquadramento de Baron-Cohen, medidos via o quociente EQ/SQ; distinto do (embora sobreposto com) monotropismo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathising%E2%80%93systemising_theory · revisão: Greenberg & Baron-Cohen, *Empathizing-Systemizing Theory: Past, Present, and Future*.

[6] Autistic Scholar — "*Revisiting monotropism*" (AuDHD como túneis concorrentes/instáveis; referências Grotewiel et al. 2022 sobre hiperfoco do TDAH como construto distinto). Conta fenomenológico/comunitário, não uma descoberta de pontuação do MQ. Arquivo local: `sources/13-revisiting-monotropism-autisticscholar.html` ·

<https://www.autisticscholar.com/monotropism>

[7] Green, S. A. & Ben-Sasson, A. (2010). *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship?* J. Autism and Developmental Disorders. PMC2980623 — hiper-responsividade sensorial, condicionamento de contexto e a rota de sobrecarga. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623>

[8] Oakley, B. et al. / literatura de ansiedade no autismo — ansiedade e ruminação elevadas na população autista/TDAH (citado via o brief panorâmico de comorbilidade do projeto para o substrato de ansiedade).

[9] Meier, S. M. et al. / meta-análises da concordância autismo–TOC — ~17% das pessoas autistas cumprem os critérios de TOC (vs ~1–2% população em geral); ~17% das crianças com TOC mostram sintomas autistas ligeiros. Resumido via Move Up ABA citando pesquisa de 2015 e a visão geral The Transmitter/Spectrum.

<https://www.thetransmitter.org/spectrum/sweeping-study-underscores-autisms-overlap-with-obsessions> · meta-análise autismo↔TOC:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11048346>

[10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "*Autism is the arena and OCD is the lion*": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitativo). PMC11497754 — a distinção ego-sintónico (interesses) vs ego-distónico (compulsões).

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754>

[11] Autism Society (2025). *Autistic Meltdowns and Shutdowns* — meltdown (externalizante) e shutdown (retirada internalizante) como respostas involuntárias a stress/input sensorial esmagador.

https://autismsociety.org/wp-content/uploads/2025/07/AutismSociety_Autistic-Meltdowns-Shutdowns_2025-06V2F_Digital.pdf

- [12] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia* (preprint/qualitativo). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — dificuldade em iniciar, parar e alternar tarefas "não sob controlo consciente". Arquivo local: [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](#) · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>
- [13] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer — inércia autista: de origem comunitária, agora revista por pares; cita Carls-Diamante & Laciny 2024, Greaves-Lord et al. 2023, Buckle 2021, Heasman 2024, Rapaport 2024. <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>
- [14] Neurodivergent Insights — *Monotropism* (glossário) e *ADHD vs Autism vs OCD* (sobreposição tripla). Recurso comunitário/clínico a enquadrar a cisão monotrópica e as sobreposições. <https://neurodivergentinsights.com/glossary/monotropism> · <https://neurodivergentinsights.com/adhd-vs-autism-vs-ocd>
- [15] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143. doi:10.1089/aut.2019.0079 — exaustão crónica, perda de competências, tolerância reduzida ao estímulo; por stress de vida crónico e incompatibilidade de expectativas e capacidades. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
- [16] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — definição de consenso: exaustão, retirada, problemas de cognição, competências de vida diária reduzidas, aumento de traços autistas. <https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>
-

Complementa o brief panorâmico mais completo do projeto: [outputs/monotropism-comorbidity-landscape.md](#) (que cobre perturbações alimentares, acumulação, agorafobia, evitamento de

exigências/PDA e o problema da dupla empatia). Este brief foca-se em verificar o enquadramento de quatro clusters acima e não repete esse material.